



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN PENGORGANISASIAN
INSTALASI FARMASI**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang
Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874
Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor : 536.5/I-PDM/DIR/V/2025

Tentang
Pedoman Pengorganisasian Instalasi Farmasi

Disusun oleh :
Kepala Instalasi Farmasi



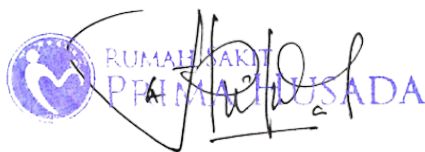
(apt. Yuanita Eka Lestari, S.Farm)

Disetujui oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M. Kes. AFP)

Ditetapkan oleh :
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Nur Mazidah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Pedoman Pengorganisasian Instalasi Farmasi RS Prima Husada Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS Prima Husada.

Pedoman Pengorganisasian Instalasi Farmasi RS Prima Husada Tahun 2025 ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2025 meliputi gambaran umum Rumah Sakit Prima Husada hingga struktur organisasi Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Pengorganisasian Instalasi Farmasi RS Prima Husada Tahun 2025 ini, mutu pelayanan dan keselamatan petugas rumah sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Malang, 30 Mei 2025

Direktur Rumah Sakit Prima Husada,

dr. Nur Mazidah

TIM PENYUSUN

PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI FARMASI

1. dr. Nur Mazidah
2. Putri Indah Purnamasari, A.Md.Keb.
3. apt. Yuanita Eka Lestari, S.Farm
4. apt. Diryati Barin Putri, S.Farm
5. apt. Pipin Purwa Ningrum, S.Farm
6. apt. Rifdah Bunga Kwintana, S.Farm
7. apt. Ajeng Janani, S.Farm
8. apt. Asharul Fahrizi, S.Farm
9. apt. Gadis Arivia, S.Farm
10. apt. Fadilah Maulana Irham Ashari, S.Farm
11. apt. Guspa Gayatri Azmi, S.Farm
12. apt. Susanti, S.Farm
13. apt. Dita Ariesa Putri Prajoko, S.Farm
14. apt. Shindy Ariesta Dewiadjie, S.Farm

DAFTAR ISI

SAMPUL

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR..... i

TIM PENYUSUN..... ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL v

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT vi

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Dasar Hukum 1

 1.3 Maksud dan Tujuan..... 1

 1.3.1 Maksud..... 1

 1.3.2 Tujuan..... 2

BAB II GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA..... 3

 2.1 Deskripsi RS Prima Husada 3

 2.2 Sejarah Institusi RS Prima Husada 3

BAB III VISI, MISI, NILAI, DAN TUJUAN 5

 3.1 Visi..... 5

 3.2 Misi 5

 3.3 Motto..... 5

 3.4 Landasan 7 Nilai Budi Utama 5

 3.5 Tujuan..... 5

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI RS PRIMA HUSADA..... 6

 4.1 Bagan Organisasi 6

 4.2 Pengertian 7

BAB V STRUKTUR ORGANISASI INSTALASI FARMASI..... 9

 5.1 Struktur Organisasi Instalasi Farmasi RS Prima Husada 9

BAB VI URAIAN JABATAN 10

 6.1 Persyaratan Jabatan..... 10

 6.2 Uraian Tugas..... 10

 6.3 Tanggung Jawab..... 12

 6.3 Wewenang 13

 6.4 Tugas Klinis..... 13

BAB VII TATA HUBUNGAN KERJA 18

 7.1 Tata Hubungan Kerja 18

 7.2 Pola Hubungan Kerja..... 18

 7.2.1 Pola Hubungan dengan Instalasi/ Unit Pelayanan Medis 18

 7.2.2 Pola Hubungan dengan Instalasi/ Unit Penunjang Medis..... 18

BAB VIII POLA KETENAGAAN..... 21

 8.1 Pola Ketenagaan..... 21

 8.2 Penempatan dan Penempatan Kembali Staf 21

 8.3 Evaluasi dan Pemutakhiran Staf..... 22

 8.4 Seleksi Calon Karyawan 22

 8.5 Pengembangan SDM..... 23

BAB IX PROGRAM ORIENTASI 24

 9.1 Orientasi Apoteker 24

 9.2 Orientasi Tenaga Vokasi Farmasi 25

BAB X PERTEMUAN / RAPAT 28

 10.1 Rapat Rutin 28

 10.2 Rapat Insidentil..... 28

BAB XI PELAPORAN 29

 11.1 Laporan Harian..... 29

 11.2 Laporan Bulanan..... 29

 11.2 Laporan Tahunan..... 30

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tugas klinis apoteker.....13

Tabel 2. Tugas klinis Tenaga Vokasi Farmasi15

Tabel 3. Pola hubungan dengan instalasi/ unit pelayanan medis18

Tabel 4. Pola hubungan dengan instalasi/ unit penunjang medis19

Tabel 5. Pola ketenagaan.....21

Tabel 6. Orientasi apoteker24

Tabel 7. Orientasi Tenaga Vokasi Farmasi.....25



**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 536.5/I-PDM/DIR/V/2025**

**TENTANG
PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI FARMASI**

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan perlu menjamin aksesibilitas obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu;
- b. bahwa Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 397.1/I-PDM/IFRS/V/2023 tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Farmasi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan rumah sakit sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Farmasi.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;
9. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 263/DPM/I-KEP/DIR/I/2025 Tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang;
10. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 390/I-KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI
FARMASI.**

Pasal 1

Pedoman Pengorganisasian Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.



Pasal 2

Pedoman Pengorganisasian Instalasi Farmasi digunakan sebagai acuan dalam Organisasi Instalasi Farmasi di Rumah Sakit Prima Husada.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 397.1/I-PDM/IFRS/V/2023 tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Farmasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang,
pada tanggal 30 Mei 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,

dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA
HUSADA
NOMOR : 536.5/I-PDM/DIR/V/2025
TENTANG
PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI
FARMASI

PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI FARMASI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan yang paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) rehabilitatif dan pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat. Rumah sakit menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik secara perorangan maupun kelompok secara paripurna yang meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Pedoman organisasi rumah sakit menyatakan bahwa rumah sakit harus melaksanakan beberapa fungsi, satu diantaranya adalah fungsi menyelenggarakan pelayanan penunjang medik dan nonmedik. Dalam hal penunjang medik, salah satu pelayanan yang penting adalah pelayanan farmasi. Instalasi farmasi di rumah sakit merupakan satu-satunya unit di rumah sakit yang mengadakan barang farmasi yang beredar di rumah sakit serta bertanggung jawab atas pengadaan dan penyajian informasi obat yang siap pakai bagi semua pihak di rumah sakit, baik petugas maupun pasien. Instalasi farmasi di rumah sakit harus memiliki organisasi yang dipimpin oleh apoteker dan dibantu oleh Tenaga Vokasi Farmasi.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan.
9. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 263/DPM/I-KEP/DIR/II/2025 Tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang.

-
10. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 773.145/I-KEP/DIR/VI/2023 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari pedoman pengorganisasian instalasi farmasi ini adalah sebagai acuan pola pengorganisasian di Rumah Sakit Prima Husada.

1.3.2 Tujuan

Salah satu bagian dari dokumentasi proses pengorganisasian Rumah Sakit Prima Husada sebagai bahan evaluasi proses pengorganisasian kedepannya.

BAB II

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

2.1 Deskripsi RS Prima Husada

Rumah Sakit Prima Husada berlokasi di Banjararum Selatan No 3 – 7 Mondoroko, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang 65153, Jawa Timur, Indonesia. Telp. 0341 – 458679, 458916, Fax: 0341 – 441874, Email sekretariat@malang.rs.primahusada.com, website www.rs-primahusada.com.

Rumah Sakit Prima Husada adalah salah satu Rumah Sakit yang memberikan pelayanan langsung khususnya pelayanan kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur dan memiliki 3 Kepala Bidang yaitu Kepala Bidang Pelayanan Medis, Kepala Bidang Penunjang Medis, dan Kepala Bidang Umum dan Operasional.

Rumah Sakit Prima Husada dengan pelayanan meliputi pelayanan Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Kamar Operasi, Penunjang Medik, dan Penunjang Non Medik, serta Instalasi Rawat Inap yang terdiri dari kelas I, II, III, VIP dan VVIP.

Dalam upaya memberikan pelayanannya, rumah sakit dituntut memberikan pelayanan sebaik – baiknya sebagai public service. Meningkatnya tuntutan dapat dilihat dengan munculnya kritik – kritik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan yang diberikan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Rumah Sakit Prima Husada perlu menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan secara bertahap melalui upaya program peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.

2.1 Sejarah Institusi RS Prima Husada

Berawal dari Praktek pribadi dr. Sadi Hariono, MMRS sebagai dokter umum sejak tahun 1990 di Banjararum Selatan No. 3B, kami telah mengabdikan diri melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Seiring dengan perkembangan penduduk dan peningkatan kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang lebih luas, maka kami pun berupaya mengembangkan diri untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap, sehingga mengantarkan kami pada berdirinya Rumah Sakit Prima Husada.

Perjalanan Peningkatan Status Pelayanan :

Tahun 1990 – 2005	: Praktek Pribadi Dokter Umum
Tahun 2005 – 2009	: Balai Pengobatan Prima Husada
Agustus 2009	: Klinik Rawat Inap Layanan Medik Dasar
Mei 2010	: Menjadi Rumah Sakit Umum dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang
Tahun 2010 – 2014	: Izin Operasional Rumah Sakit Sementara
Februari 2015	: Izin Operasional Rumah Sakit Tetap
Februari 2016	: Penetapan Rumah Sakit Tipe C
Maret 2016	: Akreditasi Paripurna
Desember 2016	: Penghargaan Rumah Sakit Trauma Center terbaik se Malang Raya Tahun 2016
April 2017	: Juara 1 Pelayanan dan Respon terbaik (Dinkes Kab. Malang)
Desember 2017	: Penghargaan Rumah Sakit Trauma Center terbaik se

	Jawa Timur Tahun 2017
Desember 2017	: Pengembangan Gedung DPM
Februari 2018	: Menjadi tempat dokter internsip
Maret 2020	: Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penyakit Covid-19 di Jawa Timur (Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/125/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penyakit Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur
Desember 2022	: Akreditasi Paripurna

BAB III

VISI, MISI, FALSAFAH, NILAI, DAN TUJUAN

3.1 Visi

Rumah Sakit Prima Husada memiliki visi :

“ Menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat.”

3.2 Misi

Rumah Sakit Prima Husada memiliki misi :

1. Memberi pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat dan akurat.
2. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien.
3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan.

3.3 Motto

Rumah Sakit Prima Husada memiliki motto :

“Sahabat Menuju Sehat”

3.4 Landasan 7 Nilai Budi Utama

Rumah Sakit Prima Husada memiliki Landasan 7 Nilai Budi Utama :

1. Jujur
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

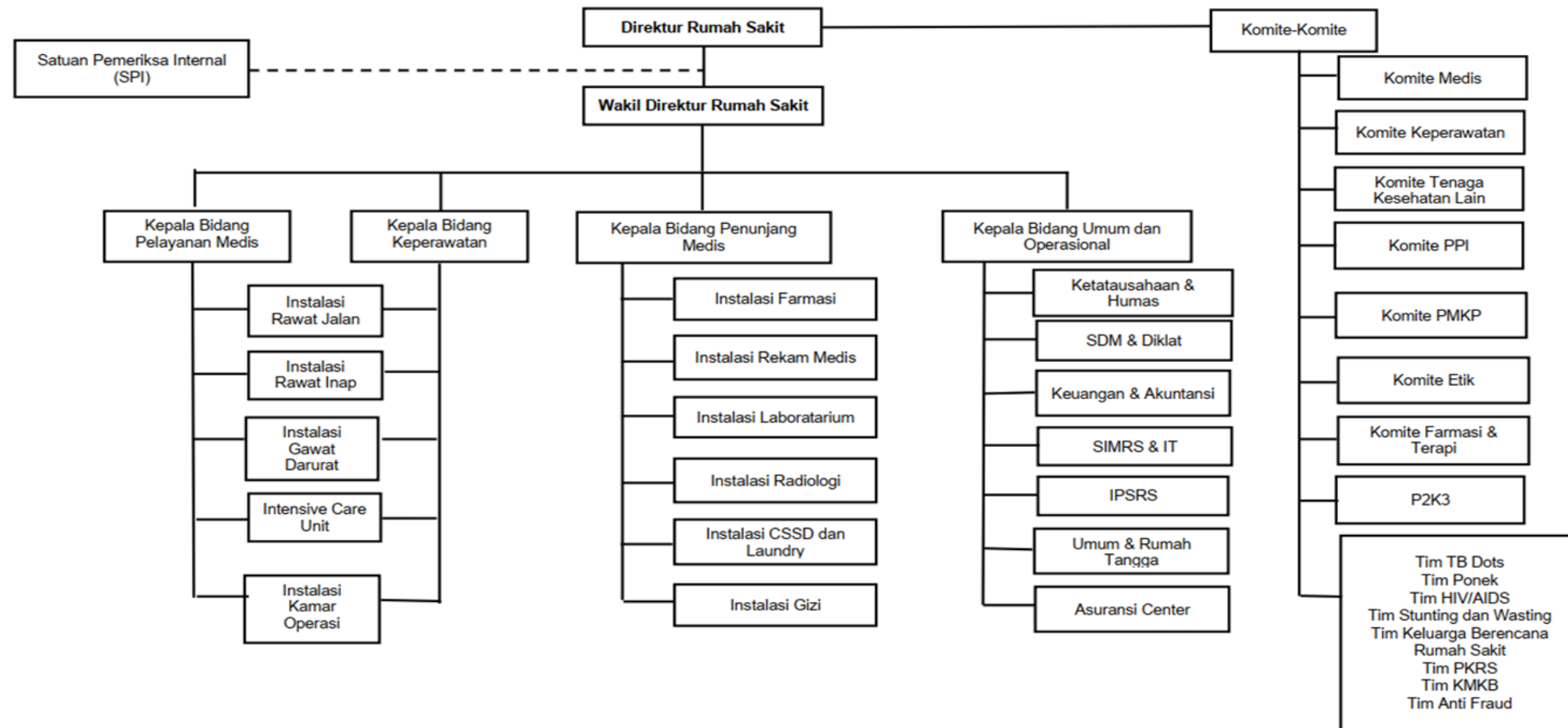
3.5 Tujuan

Rumah Sakit Prima Husada memiliki tujuan untuk mewujudkan visi dan misi Rumah Sakit Prima Husada.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI RS PRIMA HUSADA

4.1 Bagan Organisasi



4.2 Pengertian

1. Unit Struktural

a. Direktur

Adalah kepala atau pejabat tertinggi di Rumah Sakit Prima Husada

b. Kepala Bidang / Kepala Bagian

Adalah pejabat yang membantu Direktur dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan bidang masing-masing yaitu :

- 1) Kepala Bidang Pelayanan Medik membantu Direktur dalam bidang Pelayanan Rumah Sakit
- 2) Kepala Bidang Keperawatan membantu Direktur bidang keperawatan Rumah Sakit khususnya dalam keperawatan
- 3) Kepala Bidang Penunjang Medis membantu Direktur dalam bidang Penunjang Rumah Sakit
- 4) Kepala Bidang Umum dan Operasional membantu Direktur dalam bagian :
 - a) SDM yang meliputi ketenagakerjaan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.
 - b) Keuangan dan Akutansi meliputi keuangan, akutansi dan pajak rumah sakit.
 - c) Umum meliputi : Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, SIMRS, Rumah Tangga, Humas dan Pemasaran, Manajemen Kontrak dan Pengaduan Pelayanan serta hubungan dengan pihak eksternal.

2. Kepala Instalasi dan Kepala Bagian

Adalah suatu wadah struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dan memiliki fungsi tertentu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rumah sakit baik berfungsi pelayanan maupun pendukung operasional rumah sakit.

Berikut adalah daftar kepala instalasi dan kepala bagian :

- a. Kepala Instalasi Gawat Darurat
- b. Kepala Instalasi Rawat Jalan
- c. Kepala Instalasi Rawat Inap
- d. Kepala *Intensive Care Unit*
- e. Kepala Instalasi Kamar Operasi
- f. Kepala Instalasi Farmasi
- g. Kepala Instalasi Rekam Medis
- h. Kepala Instalasi Laboratorium
- i. Kepala Instalasi Radiologi
- j. Kepala Instalasi CSSD dan Laundry
- k. Kepala Instalasi Gizi
- l. Kepala Bagian Ketatausahaan dan Humas
- m. Kepala Bagian SDM
- n. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi
- o. Kepala Instalasi SIMRS
- p. Kepala Bagian IPSRS
- q. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga
- r. Kepala Bagian Asuransi Center

3. Unit Non Struktural

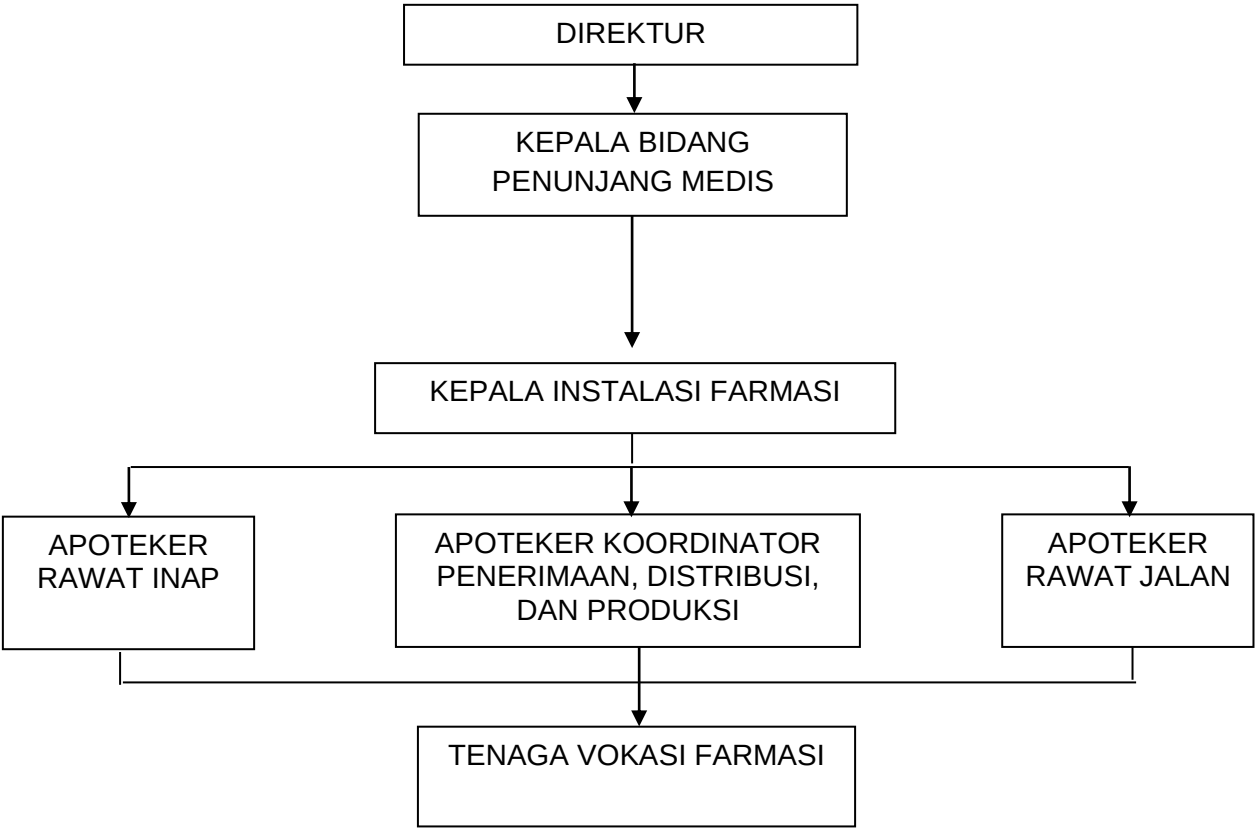
Adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli dan profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit. Komite/ Panitia/ Tim yang ada di Rumah Sakit Prima Husada adalah sebagai berikut:

-
- a. Komite Medis
 - b. Komite Keperawatan
 - c. Komite Tenaga Kesehatan Lain
 - d. Komite PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi)
 - e. Komite PMKP (Peningkatan Mutu Keselamatan Pasien)
 - f. Komite Etik
 - g. Komite Farmasi dan Terapi
 - h. Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba
 - i. Panitia P2K3 (Panitia Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit)
 - j. Tim TB DOTS
 - k. Tim PONEK
 - l. Tim HIV/AIDS
 - m. Tim Stunting dan Wasting
 - n. Tim Keluarga dan Berencana Rumah Sakit
 - o. Tim PKRS (Promosi Kesehatan Rumah Sakit)
 - p. Tim KMKB (Kendali Mutu Kendali Biaya)
 - q. Tim Anti Fraud

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI INSTALASI FARMASI

5.1 Struktur Organisasi Instalasi Farmasi RS Prima Husada



BAB VI

URAIAN JABATAN

6.1 Persyaratan Jabatan

1. Kepala Instalasi
 - a. Pendidikan :
 - Lulusan S1 Apoteker
 - Memiliki STRA dan SIPA Apoteker Penanggung Jawab yang masih berlaku, Surat sumpah Apoteker
 - b. Pengetahuan dan Keterampilan :

Memiliki keterampilan dalam perencanaan, penggerak dan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi
 - c. Pengalaman :

Pengalaman bekerja di Instalasi Farmasi minimal 3 tahun
2. Apoteker Rawat Inap, Apoteker Rawat Jalan
 - a. Pendidikan :
 - Lulusan S1 Apoteker
 - Memiliki STRA dan SIPA Apoteker Pendamping yang masih berlaku, Surat sumpah Apoteker
 - b. Pengetahuan dan Keterampilan :

Memiliki keterampilan dalam perencanaan, penggerak dan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi
 - c. Pengalaman :

Pengalaman di bidang klinis minimal 1 tahun
3. Apoteker Koordinator Penerimaan, Distribusi, dan Produksi
 - a. Pendidikan :
 - Lulusan S1 Apoteker
 - Memiliki STRA dan SIPA Apoteker Pendamping yang masih berlaku, Surat sumpah Apoteker
 - b. Pengetahuan dan Keterampilan :

Memiliki keterampilan dalam perencanaan, penggerak dan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi
 - c. Pengalaman :

Pengalaman di bidang pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan bahan berbahaya dan beracun minimal 1 tahun.
4. Tenaga Vokasi Farmasi
 - a. Pendidikan :
 - Lulusan D3
 - Memiliki Surat Tanda Registrasi Tenaga Vokasi Farmasi dan Surat Izin Praktek (SIP)
 - b. Pengetahuan dan Keterampilan :

Keterampilan dalam pelayanan Farmasi
 - c. Pengalaman :

Pengalaman di bidang klinis minimal 1 tahun

6.2 Uraian Tugas

- Kepala Instalasi

Uraian tugas kepala instalasi:

 - Menyusun dan melaksanakan perencanaan program dan anggaran Instalasi Farmasi terkait SDM, Fasilitas, Pengembangan Pelayanan, Mutu, Keselamatan Pasien, dan Keselamatan Kerja Instalasi Farmasi disesuaikan dan/atau berdasarkan peraturan perundangan dan hukum yang berlaku.

-
- Berkoordinasi dengan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien dalam menyusun rancang ulang program peningkatan mutu di Instalasi Farmasi dan melaksanakannya.
 - Menyusun dan melaksanakan program orientasi untuk pelaksana.
 - Menyusun perencanaan dan memastikan keberadaan dan pembaharuan perijinan bagi staf, fasilitas, dan hal-hal terkait di unitnya.
 - Merencanakan dan melaksanakan kerjasama dengan unit atau instansi lain sesuai kebutuhan unit.
 - Menyusun rencana kerja sesuai tujuan dan target pelayanan yang ditetapkan oleh rumah sakit.
 - Melakukan koordinasi sebagai upaya peningkatan kinerja dan mutu pelayanan.
 - Menetapkan pembagian pekerjaan, batasan tugas, tanggungjawab, serta wewenang dan hubungan kerja yang jelas.
 - Membimbing dan melakukan fungsi pengawasan terhadap apoteker pendamping dan pelaksana.
 - Menyiapkan sarana, prasarana, fasilitas, dan lingkungan kerja yang sesuai untuk kelancaran pelayanan dan memudahkan pasien dalam menerima pelayanan.
 - Memastikan proses pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - Memastikan pelayanan pasien sesuai pedoman pelayanan farmasi dan standar prosedur operasional yang berlaku.
 - Memelihara peralatan medis agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai.
 - Melakukan sosialisasi mengenai peraturan / tata tertib yang berlaku di rumah sakit dan menjaga agar seluruh sumber daya manusia di unitnya selalu patuh terhadap peraturan di rumah sakit.
 - Menjaga fasilitas yang ada, melakukan sosialisasi cara penggunaan, pemeliharaan, dan evaluasi terkait umur pemakaian fasilitas yang ada di unitnya.
 - Menciptakan hubungan kerjasama yang baik dengan sesama karyawan maupun pasien dan keluarganya.
 - Mengikuti pertemuan berkala yang diadakan secara rutin.
 - Menjaga proses kontrol mutu terhadap ikatan kerja sama yang ada.
 - Melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap program dan anggaran yang telah dibuat.
2. Apoteker Rawat Inap, Apoteker Rawat Jalan
- Uraian tugas apoteker rawat inap, apoteker rawat jalan :
- Membantu menyusun dan melaksanakan program orientasi untuk pelaksana.
 - Membantu menyusun perencanaan dan memastikan keberadaan dan pembaharuan perijinan bagi staf, fasilitas, dan hal-hal terkait di unitnya.
 - Melaksanakan kerjasama dengan unit atau instansi lain sesuai kebutuhan unit.
 - Melakukan koordinasi sebagai upaya peningkatan kinerja dan mutu pelayanan.
 - Membimbing dan melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksana.
 - Membantu menyiapkan sarana, prasarana, fasilitas, dan lingkungan kerja yang sesuai untuk kelancaran pelayanan dan memudahkan pasien dalam menerima pelayanan.
 - Melaksanakan pelayanan farmasi klinik sesuai pedoman pelayanan farmasi dan standar prosedur operasional yang berlaku.
 - Memelihara peralatan medis agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai.
 - Membantu melakukan sosialisasi mengenai peraturan / tata tertib yang berlaku di rumah sakit dan menjaga agar seluruh sumber daya manusia di unitnya selalu patuh terhadap peraturan di rumah sakit.
 - Membantu menjaga fasilitas yang ada, melakukan sosialisasi cara penggunaan, pemeliharaan, dan evaluasi terkait umur pemakaian fasilitas yang ada di unitnya.
 - Menciptakan hubungan kerjasama yang baik dengan sesama karyawan maupun

-
- pasien dan keluarganya.
- Mengikuti pertemuan berkala yang diadakan secara rutin.
 - Melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap program dan anggaran yang telah dibuat.
3. Apoteker Koordinator Penerimaan, Distribusi, dan Produksi
- Uraian tugas apoteker koordinator penerimaan, distribusi, dan produksi :
- Memilih sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan pelayanan rumah sakit.
 - Merencanakan kebutuhan sediaan farmasi secara optimal.
 - Mengadakan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai berpedoman pada perencanaan yang telah dibuat sesuai ketentuan yang berlaku.
 - memproduksi sediaan farmasi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan.
 - Menerima sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan spesifikasi yang berlaku.
 - Menyimpan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan kefarmasian;
 - Mendistribusikan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai ke masing-masing unit pelayanan di rumah sakit;
 - Memusnahkan dan menarik sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang tidak memenuhi persyaratan mutu.
 - Mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
 - Mencegah dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
 - Melakukan pencatatan dan pelaporan setiap kegiatan
4. Tenaga Vokasi Farmasi
- Uraian tugas Tenaga Vokasi Farmasi :
- Membantu apoteker untuk melakukan tugas rutin di instalasi farmasi rumah sakit.
 - Memeriksa ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di unit kerja.
 - Memeriksa persediaan sediaan farmasi yang mendekati waktu kadaluarsa.
 - Membuat usulan penanganan obat yang mendekati tanggal kadaluarsa.
 - Menerima dan melakukan menyimpan sediaan farmasi sesuai golongannya
 - Menyimpan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai sifat fisika dan kimia berdasarkan informasi dalam kemasan.
 - Melakukan telaah resep dibawah pengawasan apoteker.
 - Melakukan input obat kronis pada sistem BPJS.
 - Melakukan penempelan label untuk obat yang memiliki kewaspadaan tinggi.
 - Menyiapkan sediaan farmasi sesuai prosedur.
 - Meracik sediaan farmasi di bawah pengawasan apoteker.
 - Menulis etiket dan menempelkan label pada kemasan.
 - Melakukan pengecekan etiket dan label.
 - Memberikan edukasi dan informasi obat

6.3 Tanggung Jawab

1. Kepala Instalasi

Tanggung jawab kepala instalasi :

- Bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit Prima Husada.
- Bertanggungjawab atas pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik rumah sakit.

2. Apoteker Rawat Inap, Apoteker Rawat Jalan

Tanggung jawab apoteker rawat inap, apoteker rawat jalan :

- Bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi Farmasi.

- Bertanggung jawab atas pelayanan dan ketenagaan keseharian di Instalasi Farmasi.
3. Apoteker Koordinator Penerimaan, Distribusi, dan Produksi
Tanggung jawab apoteker koordinator penerimaan, distribusi, dan produksi :
 - Bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi Farmasi.
 - Bertanggung jawab atas pelayanan dan ketenagaan keseharian di Instalasi Farmasi.
 4. Tenaga Vokasi Farmasi
Tanggung jawab tugas Tenaga Vokasi Farmasi :
 - Bertanggung jawab kepada Apoteker dan Kepala Instalasi.
 - Bertanggung jawab atas pelayanan keseharian di Instalasi Farmasi.

6.4 Wewenang

1. Kepala Instalasi
Wewenang kepala instalasi:
 - Menandatangani surat pesanan obat sesuai dengan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit.
 - Mengusulkan rencana kebutuhan tenaga farmasi dari segi jumlah maupun kualifikasi di instalasi farmasi.
 - Mengevaluasi perencanaan kebutuhan dan mengajukan permintaan pengadaan barang-barang farmasi baik untuk bulanan ataupun persediaan harian.
 - Memantau penerimaan dan penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
 - Memantau pendistribusian dan penjualan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
 - Memantau penerapan SOP dan mengevaluasi.
2. Apoteker Rawat Inap, Apoteker Rawat Jalan
Wewenang apoteker rawat inap, apoteker rawat jalan :
 - Membantu Kepala Instalasi untuk melakukan tugas rutin di instalasi farmasi rumah sakit.
 - Melakukan supervisi sesuai dengan penugasannya.
3. Apoteker Koordinator Penerimaan, Distribusi, dan Produksi
Wewenang apoteker koordinator penerimaan, distribusi, dan produksi :
 - Membantu Kepala Instalasi untuk melakukan tugas rutin di gudang instalasi farmasi rumah sakit meliputi penerimaan, distribusi, dan produksi sediaan farmasi.
 - Melakukan supervisi sesuai dengan penugasannya.
4. Tenaga Vokasi Farmasi
Wewenang tugas Tenaga Vokasi Farmasi :
 - Memberikan pelayanan kefarmasian kepada pasien dibawah pengawasan apoteker.

6.5 Tugas Klinis

Tugas klinis yang dimaksud adalah seseorang yang bekerja di bidang manajemen mempunyai uraian tugas jabatan dan uraian tugas fungsional dan dilengkapi oleh SPK dan RKK

a. Apoteker

Tabel 1. Tugas klinis apoteker

No	Kompetensi
1.	PERENCANAAN
	a. Dapat mengajukan perencanaan sediaan farmasi ke Kepala Instalasi
	b. Memberikan pertimbangan pemilihan/ penggunaan obat dalam suatu kurun waktu
2.	PENGADAAN
	a. Memberikan pengkajian terhadap seleksi obat

No	Kompetensi
	b. Memberikan pertimbangan tentang pemilihan metode teknis pengadaan
	c. Memberikan penilaian tentang jumlah dan kesesuaian antara kebutuhan dengan dana
	d. Memberikan pertimbangan tentang pemilihan pemasok
	e. Membuat surat pemesanan barang
	f. Memantau proses pengadaan
	g. Memantau dan evaluasi pengadaan obat baru
	h. Memantau proses pembayaran
	i. Melakukan proses monitoring dan evaluasi sistem pengadaan di RS
3.	PENERIMAAN
	a. Menerima faktur pembelian sediaan farmasi
	b. Mengecek kebenaran jumlah kemasan, kondisi kemasan seperti yang disyaratkan, jumlah satuan dalam tiap kemasan, kebenaran identitas produk, jangka waktu kadaluarsa, dan jenis produk yang diterima
	c. Melakukan dokumentasi proses penerimaan
	d. Menerima faktur pemberian sediaan OKT (Obat Keras Tertentu)
4.	PENYIMPANAN
	a. Melakukan supervisi dan kontrol suhu ruangan
	b. Melakukan supervisi terkait penempelan label obat, stiker penandaan LASA dan High Alert
	c. Melakukan supervisi terkait penyimpanan sediaan farmasi, gas medis, B3, dan obat radioaktif
	d. Melakukan supervisi terkait penyimpanan OKT
	e. Melakukan supervisi penyimpanan floor stock yang tersedia di unit RS
	f. Melakukan supervisi terkait box emergensi di ruangan
	g. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait sistem penyimpanan di RS
5.	DISTRIBUSI
	a. Dapat akses peresepan secara elektronik di billing SIMRS
	b. Memberikan KIE kepada pasien dan atau tenaga medis lain
	c. Melakukan supervisi terkait telaah resep
	d. Melakukan supervisi terkait penyiapan, pemberian etiket, hingga penyerahan obat ke pasien dan atau perawat
	e. Melakukan supervisi dan laporan evaluasi terkait kegiatan distribusi di RS
	f. Melakukan supervisi terkait penyimpanan obat di ruangan rawat inap
6.	PEMUSNAHAN DAN PENARIKAN
	a. Membuat berita acara pemusnahan obat
	b. Membuat berita acara penarikan obat
	c. Membuat laporan pemusnahan dan atau penarikan obat kepada Kepala Instalasi Farmasi
	d. Melakukan kegiatan pemusnahan obat
	e. Melakukan kegiatan penarikan obat
7.	PERESEPAN
	a. Melakukan pengkajian resep
	b. Membuat laporan kajian data terkait resep lengkap, peresepan di luar formularium, dan resep polifarmasi
8.	PENYIAPAN OBAT
	a. Melakukan penyiapan obat
	b. Melakukan penyiapan sediaan steril
	c. Melakukan penyiapan obat narkotika/ psikotropika
	d. Melakukan pembuatan handsrub
	e. Melakukan supervisi terhadap penyiapan obat

No	Kompetensi
	f. Melakukan tindak lanjut terhadap kesalahan penyiapan obat
	g. Melakukan supervisi terhadap lembar verifikasi penyiapan obat
	h. Melakukan supervisi terkait kebersihan, kerapihan, dan kesesuaian tempat kerja untuk penyiapan obat
9.	REKONSILIASI OBAT
	a. Melakukan penulisan lembar rekonsiliasi obat
	b. Melakukan penulisan riwayat penggunaan obat pasien
	c. Melakukan supervisi terkait kepatuhan penulisan lembar rekonsiliasi obat
10.	KONSELING DAN PEMBERIAN INFORMASI OBAT
	a. Memberikan konseling kepada pasien
	b. Memberikan informasi obat kepada pasien, keluarga pasien, dan atau tenaga medis lain
	c. Memberikan materi konseling dan informasi obat
11.	VISITE
	a. Melakukan visite pasien di rawat inap
	b. Menuliskan hasil visite pasien di lembar Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT)
	c. Memberikan rekomendasi jam pemberian terapi pasien
	d. Memberikan rekomendasi terkait pengobatan jika terjadi ROTD
12.	PEMANTAUAN TERAPI OBAT
	a. Melakukan pemantauan terapi obat pada kriteria pasien yang telah ditentukan
	b. Memberikan rekomendasi terkait pengobatan jika terjadi ROTD
13.	MONITORING EFEK SAMPING OBAT
	a. Melakukan monitoring terkait efek samping obat
	b. Memberikan rekomendasi penanganan jika terjadi efek samping obat
14.	CATATAN PENGGUNAAN OBAT PASIEN
	a. Melakukan pencatatan penggunaan obat pasien
15.	KODE ETIK
	a. Menjelaskan penerapan Kode Etik dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia dalam praktik sehari-hari
	b. Menerapkan pertimbangan profesional dalam melakukan praktik kefarmasian dengan mengindahkan kode etik dan disiplin
	c. Menjelaskan ketentuan perundangan bidang kefarmasian secara khusus dan ketentuan bidang kesehatan secara umum, dan penerapannya dalam praktik

b. Tenaga Vokasi Farmasi

Tabel 2. Tugas klinis Tenaga Vokasi Farmasi

No	Kompetensi
1.	PERENCANAAN
	a. Dapat mengajukan perencanaan sediaan farmasi ke Kepala Instalasi
	b. Memberikan pertimbangan pemilihan/ penggunaan obat dalam suatu kurun waktu
2.	PENGADAAN
	a. Memberikan pengkajian terhadap seleksi obat
	b. Memberikan pertimbangan tentang pemilihan metode teknis pengadaan
	c. Memberikan penilaian tentang jumlah dan kesesuaian antara kebutuhan dengan dana
	d. Memberikan pertimbangan tentang pemilihan pemasok

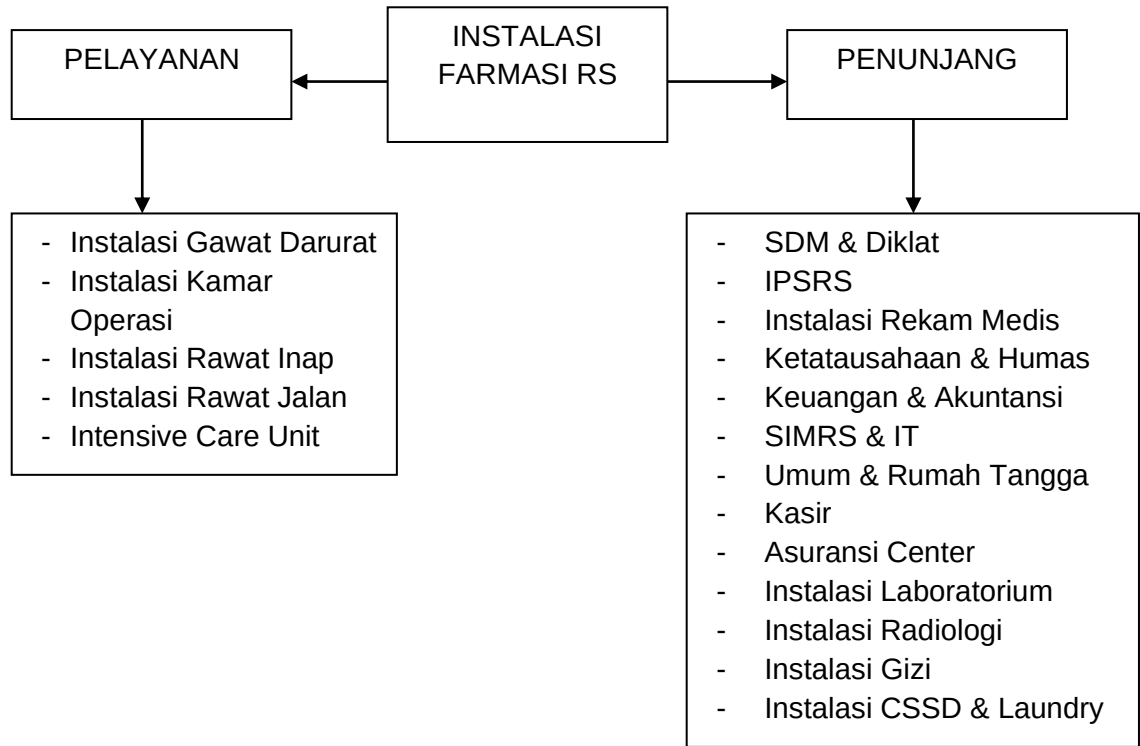
No	Kompetensi
	e. Membuat surat pemesanan barang
3.	PENERIMAAN
	a. Menerima faktur pembelian sediaan farmasi
	b. Mengecek kebenaran jumlah kemasan, kondisi kemasan seperti yang disyaratkan, jumlah satuan dalam tiap kemasan, kebenaran identitas produk, jangka waktu kadaluarsa, dan jenis produk yang diterima
	c. Melakukan dokumentasi proses penerimaan
	d. Menerima faktur pemberian sediaan OKT (Obat Keras Tertentu)
4.	PENYIMPANAN
	a. Melakukan kontrol suhu ruangan
	b. Melakukan penempelan label obat, stiker penandaan LASA dan High Alert
	c. Melakukan penyimpanan sediaan farmasi, gas medis, B3, dan obat radioaktif sesuai aturan
	d. Melakukan penyimpanan OKT
	e. Melakukan penyimpanan floor stock yang tersedia di unit RS
	f. Melakukan penggantian obat dalam box emergensi di ruangan
5.	DISTRIBUSI
	a. Dapat akses peresepan secara elektronik di billing SIMRS
	b. Memberikan KIE kepada pasien dan atau tenaga medis lain
	c. Melakukan telaah resep
	d. Melakukan penyiapan, pemberian etiket, hingga penyerahan obat ke pasien dan atau perawat
6.	PEMUSNAHAN DAN PENARIKAN
	a. Membuat berita acara pemusnahan obat
	b. Membuat berita acara penarikan obat
	c. Membuat laporan pemusnahan dan atau penarikan obat kepada Kepala Instalasi Farmasi
	d. Melakukan kegiatan pemusnahan obat
	e. Melakukan kegiatan penarikan obat
7.	PERESEPAN
	a. Melakukan pengkajian resep
	b. Membuat laporan kajian data terkait resep lengkap, persepan di luar formularium, dan resep polifarmasi
8.	PENYIAPAN OBAT
	a. Melakukan penyiapan obat
	b. Melakukan penyiapan sediaan steril
	c. Melakukan penyiapan obat narkotika/ psikotropika
	d. Melakukan pembuatan handsrub
	e. Melakukan tindak lanjut terhadap kesalahan penyiapan obat
	f. Melakukan verifikasi saat penyiapan obat
	g. Menjaga kebersihan, kerapian, dan kesesuaian tempat kerja untuk penyiapan obat
9.	KONSELING DAN PEMBERIAN INFORMASI OBAT
	a. Memberikan konseling kepada pasien
	b. Memberikan informasi obat kepada pasien, keluarga pasien, dan atau tenaga medis lain
	c. Memberikan materi konseling dan informasi obat
10.	MONITORING EFEK SAMPING OBAT
	a. Melakukan monitoring terkait efek samping obat
	b. Memberikan rekomendasi penanganan jika terjadi efek samping obat
11.	CATATAN PENGGUNAAN OBAT PASIEN

No	Kompetensi
	a. Melakukan pencatatan penggunaan obat pasien
12.	KODE ETIK
	a. Menjelaskan penerapan Kode Etik Tenaga Vokasi Farmasi dalam praktik sehari-hari
	b. Menerapkan pertimbangan profesional dalam melakukan praktik kefarmasian dengan mengindahkan kode etik dan disiplin
	c. Menjelaskan ketentuan perundangan bidang kefarmasian secara khusus dan ketentuan bidang kesehatan secara umum, dan penerapannya dalam praktik

BAB VII

TATA HUBUNGAN KERJA

7.1 Tata Hubungan Kerja



7.2 Pola Hubungan Kerja

7.2.1 Pola Hubungan dengan Instalasi/ Unit Pelayanan Medis

Tabel 3. Pola hubungan dengan instalasi/ unit pelayanan medis

No.	Unit/Instalasi Terkait	Uraian Hubungan Kerja
1.	Instalasi Gawat Darurat (IGD)	1. Distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan bahan berbahaya dan beracun. 2. Pelayanan resep pasien IGD. 3. Pengecekan <i>box dan trolley emergency</i> . 4. Supervisi apoteker di IGD.
2.	Instalasi Kamar Operasi (IKO)	1. Distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan bahan berbahaya dan beracun. 2. Pelayanan resep IKO. 3. Pelayanan <i>floorstock</i> IKO. 4. <i>Stock opname floorstock</i> IKO. 5. Pengecekan <i>box dan trolley emergency</i> . 6. Supervisi apoteker di IKO.
3.	Instalasi Rawat Inap (IRNA)	1. Distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan bahan berbahaya dan beracun. 2. Pelayanan resep pasien rawat inap. 3. Visite pasien rawat inap. 4. Pengecekan <i>box emergency</i> . 5. Supervisi mingguan apoteker di rawat inap. 6. Pengisian rekam medis.

		7. Pelayanan farmasi klinik oleh apoteker.
4.	Instalasi Rawat Jalan (IRJA)	1. Distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan bahan berbahaya dan beracun. 2. Pelayanan resep pasien rawat jalan. 3. Pengecekan <i>box emergency</i> 4. Pelayanan farmasi klinik oleh apoteker. 5. Supervisi mingguan apoteker.
5.	<i>Intensive Care Unit</i> (ICU)	1. Distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan bahan berbahaya dan beracun. 2. Pelayanan Resep pasien ICU. 3. Visite pasien. 4. Pengecekan <i>box emergency</i> . 5. Supervisi mingguan apoteker di ICU. 6. Pengisian rekam medis. 7. Pelayanan farmasi klinik oleh apoteker.

7.2.2 Pola Hubungan dengan Instalasi/ Unit Penunjang Medis

Tabel 4. Pola hubungan dengan instalasi/ unit penunjang medis

No.	Unit/ Instalasi Terkait	Uraian Hubungan Kerja
1.	SDM & Diklat	1. Koordinasi kebutuhan jumlah SDM. 2. Pengembangan SDM.
2.	Instalasi Prasarana dan Sarana RS (IPSR)	1. Perbaikan peralatan dan sarana instalasi farmasi. 2. Pengkondisian lingkungan area instalasi farmasi.
3.	Instalasi Rekam Medik	1. Laporan bulanan dan tahunan penggunaan obat IRJA, IRNA, IGD. 2. Kelengkapan pengisian rekam medik. 3. Pengorderan berkas
4.	Ketatausahaan & Humas	1. Keperluan data dan dokumen. 2. Survei kepuasan Pasien. 3. Standar pelayanan minimal.
5.	Keuangan & Akuntansi	1. Laporan Stock Opname. 2. Laporan penjualan umum. 3. Laporan penjualan pasien jaminan.
6.	SIMRS & IT	1. Pengecekan komputer dan perangkatnya. 2. Perbaikan program Billing SIMRS.
7.	UMUM & Rumah Tangga	1. Kebersihan ruangan. 2. Persiapan ruangan untuk <i>event</i> .
8.	Kasir	1. Pembayaran pelayanan resep pasien umum rawat jalan maupun rawat inap. 2. Pengesahan resep asuransi selain BPJS.
9	Asuransi Center	1. Pengumpulan berkas klaim obat kronis. 2. Koordinasi terkait obat INA-CBGs, obat PRB, dan obat kronis. 3. Koordinasi terkait tarif obat rawat inap dan rawat jalan
10	Instalasi Laboratorium	1. Distribusi alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan bahan berbahaya dan beracun.
11	Instalasi Radiologi	1. Distribusi alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan bahan berbahaya dan beracun.
12	Instalasi Gizi	1. Distribusi alat kesehatan, bahan medis habis

		pakai, dan produk nutrisi.
13	Instalasi CSSD & Laundry	1. Distribusi bahan medis habis pakai dan bahan berbahaya dan beracun. 2. Penerimaan kasa steril yang sudah di repack oleh CSSD

BAB VIII

POLA KETENAGAAN

8.1 Pola Ketenagaan

Dalam upaya mempersiapkan tenaga farmasi yang handal perlu adanya perencanaan SDM. Tujuannya adalah mendayagunakan sumber-sumber tersebut seefektif mungkin sehingga pada waktu yang tepat dapat disediakan sejumlah orang yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Berdasarkan Permenkes 3 tahun 2020 dan Permenkes 72 tahun 2016 maka :

Tabel 5. Pola ketenagaan

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH SDM		Keterangan
		STANDAR	KONDISI SAAT INI	
1	Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit	1 orang	1 orang	Sesuai
2	Apoteker Rawat Jalan	6 orang	5 orang	Tidak sesuai
3	Tenaga Vokasi Farmasi	27 orang	25 orang	Tidak sesuai
4	Apoteker Rawat Inap	5 orang	5 orang	Sesuai
5	Apoteker Koordinator Penerimaan, Distribusi, dan Produksi	1 orang	1 orang	Sesuai
6	Tenaga Vokasi Farmasi Penerimaan, Distribusi, dan Produksi	2 orang	1 orang	Tidak sesuai

8.2 Penempatan dan Penempatan Kembali Staf

Perencanaan kebutuhan yang tepat dengan jumlah yang mencukupi adalah hal yang sangat penting bagi asuhan pasien termasuk keterlibatan rumah sakit dalam semua kegiatan pendidikan dan riset. Penempatan (*placement*) atau penempatan kembali (*replacement*) harus memperhatikan faktor kompetensi. Sebagai contoh, seorang perawat yang memiliki kompetensi hemodialisis tidak dirotasi ke rawat jalan lain.

Pimpinan unit layanan membuat rencana pola ketenagaan dengan menggunakan proses yang sudah diakui untuk menentukan jenjang kepegawaian. Perencanaan kepegawaian meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Penempatan kembali dari satu unit layanan ke lain unit layanan karena alasan kompetensi, kebutuhan pasien, atau kekurangan staf;
 - Staf yang mempunyai kompetensi tambahan seperti pelatihan Instrumen, pelatihan Kegawatdaruratan Perinatologi, Pelatihan ICU dasar, Pelatihan Anestesi tidak dapat dirotasi ke unit lain dikarenakan terdapat unit prioritas yang khusus membutuhkan kompetensi tambahan tersebut. Misalnya Staf yang memiliki pelatihan Instrumen, ditempatkan di Instalasi Kamar operasi, sebaliknya staf yang mempunyai kompetensi ICU dasar di tempatkan di *Instalasi Care Unit* (ICU)
 - Penempatan staf dapat dilakukan apabila dalam unit tersebut terdapat kebutuhan mendesak sedangkan staf yang dibutuhkan belum tersedia, maka staf tersebut di rotasi sementara untuk menjaga stabilitas pelayanan dengan tetap memperhatikan kualifikasi dan Rincian Kewenangan Klinis yang sesuai.
- b. Mempertimbangkan keinginan staf untuk ditempatkan kembali karena alasan nilai-nilai, kepercayaan, dan agama.

Mengkaji keinginan staf untuk ditempatkan pada unit yang sesuai berdasarkan hasil psikotest, menggali nilai kepribadian staf apakah lebih berpotensi pada unit

pelayanan atau manajemen, atau bahkan marketing yang sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.

c. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

Penempatan (*placement*) atau penempatan kembali (*replacement*) harus memperhatikan faktor kompetensi, surat penugasan klinis dan gan klinis yang telah disetujui Direktur RS Prima Husada dengan tetap mengacu pada peraturan perundan-undangan yang berlaku.

Setiap staf mempunyai tanggung jawab sesuai dengan uraian tugas dan fungsinya. Dalam hal ini kompetensi dan kewenangan menjadi dasar dalam menentukan penempatan, uraian pekerjaan, dan kriteria untuk evaluasi kinerja staf. Uraian tugas juga diperlukan untuk tenaga kesehatan profesional dengan ketentuan sebagai berikut :

- Staf yang bekerja terutama di bidang manajemen dan fungsional. Contoh, dokter spesialis bedah merangkap sebagai Kepala Instalasi Kamar Operasi dan sebagai dokter bedah harus mempunyai STR, SIP, SPK, RKK dan sebagai kepala instalasi kamar operasi mempunyai uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab;
- Seseorang dalam program pendidikan dan bekerja di bawah supervisi maka program pendidikan menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dikerjakan sesuai dengan tingkat pendidikannya;
- Bagi mereka yang diizinkan menurut peraturan perundang-undangan melakukan praktik mandiri harus dilakukan proses untuk identifikasi dan memberikan wewenang melaksanakan praktik dengan dasar latar belakang pendidikan, kompetensi, pelatihan, dan pengalaman. Persyaratan standar ini berlaku untuk semua jenis staf yang harus ada uraian tugasnya. (contoh, penugasan penuh waktu, paruh waktu, dipekerjakan, sukarela, sementara).

8.3 Evaluasi Dan Pemutakhiran Staf

- a. Pemutakhiran dan evaluasi staf dilakukan setiap satu tahun sekali dan dilaporkan tiap bulan di laporan bulanan
- b. Dihadiri oleh Direktur, Kepala Bidang, Kepala Instalasi/Ruang, SDM
- c. Setiap ada staf yang melakukan pengunduran diri
- d. Setiap penambahan jenis pelayanan, jumlah pasien dan jumlah alat yang mempengaruhi perhitungan awal pola ketenagaan

8.4 Seleksi Calon Karyawan

Seleksi calon karyawan adalah aktivitas atau usaha yang dilakukan untuk mengundang para pelamar sebanyak mungkin sehingga Instalasi Farmasi memiliki kesempatan yang luas untuk menemukan calon yang paling sesuai dengan tuntutan jabatan yang diinginkan. Seleksi calon karyawan dilakukan karena berdasarkan analisa kebutuhan tenaga, ditemukan jumlah pasien dan kegiatan tidak seimbang dengan jumlah tenaga yang ada.

Berdasarkan sumber seleksi calon karyawan dapat dibagi dua yaitu:

1. Dari dalam Rumah Sakit Prima Husada sendiri (*internal resources*)

Menarik calon dari dalam RS Prima Husada sendiri (*Internal resources*) memiliki keuntungan lebih yaitu calon sudah dikenal dengan kinerja yang baik dan proses dapat dilakukan dengan lebih cepat dibanding menarik calon dari luar RS Prima Husada. Untuk mendapatkan calon pelamar dapat melalui berkas-berkas pelamar yang masuk ke rumah sakit Prima Husada

2. Dari luar Rumah Sakit Prima Husada (*external resources*)

Proses penarikan calon dari luar RS. Prima Husada ini dapat dilakukan dengan cara iklan media cetak dan kerja sama dengan lembaga pendidikan tentang kebutuhan dengan kualifikasi tertentu.

Kriteria calon karyawan menurut standar IFRS RS Prima Husada :

1. Apoteker
 - a. Lulusan S1 Farmasi dan Profesi Apoteker.
 - b. Berasal dari Perguruan Tinggi dengan minimal akreditasi B.
 - c. Memiliki IPK Apoteker minimal 3,00.
 - d. Sehat jasmani dan rohani.
 - e. Diutamakan apoteker dengan penjurusan klinis.
 - f. Memiliki pemahaman tentang Pelayanan Farmasi RS dengan baik.
 - g. Paham CPFB (Cara Pelayanan Farmasi Baik).
 - h. Mudah bekerja secara mandiri dan tim.
2. Tenaga Vokasi Farmasi
 - a. Lulusan D3 Farmasi.
 - b. Berasal dari Perguruan Tinggi dengan minimal akreditasi B.
 - c. Memiliki IPK minimal 3,00.
 - d. Sehat jasmani dan rohani.
 - e. Memahami pekerjaan farmasi klinis.
 - f. Mudah bekerja secara mandiri dan tim.

8.5 Pengembangan SDM

Untuk meningkatkan mutu pelayanan di Instalasi Farmasi khususnya dan Rumah Sakit Prima Husada umumnya, diperlukan pembinaan/pengembangan kompetensi tenaga farmasi. Pembinaan/ pengembangan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pelaksanaan tugas dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja dan menambah pengetahuan wawasan bidang pelayanan farmasi. Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan dua cara yakni:

1. Pendidikan

Tenaga dengan pendidikan :

 - Setingkat DIII farmasi diberi izin untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan S1 farmasi.
 - Setingkat S1 farmasi diberi izin untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan Apoteker.
2. Pelatihan

Pelatihan untuk peningkatan kompetensi Apoteker dan Tenaga Vokasi Farmasi di Instalasi Farmasi dilaksanakan melalui :

 - a. *Internal Training* yaitu program pelatihan yang diselenggarakan oleh RS Prima Husada yaitu pelatihan PPI, peningkatan mutu dan keselamatan pasien, komunikasi efektif, pelatihan penanggulangan bencana dan apar, penanganan B3, manajemen resiko, pelatihan BHD, pelatihan hak pasien dan keluarga, pelatihan medication error, pelatihan penyiapan sediaan IV dan teknik aseptik.
 - b. *External Training* yaitu program pelatihan diluar rumah sakit yang diikuti sesuai dengan kebutuhan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit khususnya mutu pelayanan Instalasi Farmasi.

BAB IX

PROGRAM ORIENTASI

9.1 Orientasi Apoteker

Tabel 6. Orientasi apoteker

HARI KE	MATERI	WAKTU	METODE	PENANGGUNG JAWAB
1	Penjelasan status kepegawaian. Penjelasan program orientasi yang akan diterima pegawai, peraturan dan tata tertib masa orientasi. Kepada pegawai dikenalkan seluruh unit kerja di Rumah Sakit Prima Husada. Orientasi di unit kerja dimana pegawai ditempatkan. Pegawai diberikan berbagai materi orientasi dengan penjadwalan khusus meliputi : 1. Visi, misi, nilai, struktur organisasi 2. Perjanjian kerja 3. Etika bekerja 4. Kesejahteraan spiritual 5. <i>Service excellence</i> 6. <i>Handling complaints</i> 7. Produk produk rumah sakit 8. <i>Basic life support</i> 9. Penanggulangan bencana kebakaran 10. <i>Patient safety</i> 11. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	7 jam	Ceramah dan diskusi	SDM
2	Mempelajari Pedoman Pelayanan IFRS; Mempelajari Pedoman Pengorganisasian Instalasi Farmasi; Mempelajari Panduan UDD; Mempelajari Panduan <i>Floorstock</i>; Mempelajari Panduan Resep; Mempelajari Panduan Obat yang Perlu Diwaspadai; Mempelajari Panduan Bahan Berbahaya dan Beracun; Mempelajari SPO Instalasi Farmasi.	4 jam	Ceramah, membaca, dan diskusi	Kepala IFRS
3	Mempelajari dan praktek alur pelayanan farmasi rawat jalan; Cara menerima resep rawat jalan/inap; Pengkajian dan pelayanan resep;	7 jam	Ceramah, diskusi, dan praktek	Apoteker rawat jalan

	Mempelajari aplikasi BPJS billing <i>Fee For Service</i> ; Menyiapkan dan etiket obat pasien rawat jalan/inap; Menyerahkan obat dan KIE pasien rawat jalan/inap; Checklist dan format data yang harus dikerjakan tiap akhir shift.			
4	Mempelajari dan praktek alur pelayanan farmasi rawat inap dengan sistem UDD; Pengisian Form Daftar Pemberian Obat pasien rawat inap; Rekonsiliasi obat; Pengisian RM pasien; Visite apoteker; Pemantauan Terapi Oba; Monitoring efek samping obat beserta dokumentasi pelaporan ESO & intervensi yang dilakukan; Menyiapkan dan etiket obat rekonstitusi; Dispensing sediaan steril di ruang LAF; Mempelajari <i>items</i> pada SIMRS depo farmasi rawat inap dan depo farmasi rawat jalan.	7 jam	Ceramah diskusi, dan praktek	Apoteker rawat inap
5	Mempelajari <i>items</i> pada SIMRS gudang farmasi; Mempelajari cara penerimaan barang dari distributor; Mempelajari cara pemesanan barang ke unit pengadaan; Mempelajadi cara input faktur.	7 jam	Ceramah diskusi, dan praktek	Kepala IFRS

9.2 Orientasi Tenaga Vokasi Farmasi

Tabel 7. Orientasi Tenaga Vokasi Farmasi

HARI KE	MATERI	WAKTU	METODE	PENANGGUNG JAWAB
1	Penjelasan status kepegawaian Penjelasan program orientasi yang akan diterima pegawai, peraturan dan tata tertib masa orientasi Kepada pegawai dikenalkan seluruh unit kerja di Rumah Sakit Prima Husada Orientasi di unit kerja dimana pegawai ditempatkan Pegawai diberikan berbagai materi orientasi dengan penjadwalan khusus	7 jam	Ceramah dan diskusi	SDM

	meliputi : 1. Visi, misi, nilai, struktur organisasi; 2. Perjanjian kerja; 3. Etika bekerja; 4. Kesejahteraan spiritual; 5. <i>Service excellence</i> ; 6. <i>Handling complaints</i> ; 7. Produk produk rumah sakit; 8. <i>Basic life support</i> 9. Penanggulangan bencana kebakaran; 10. Patient safety; 11. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi			
2	Mempelajari Pedoman Pelayanan IFRS; Mempelajari Pedoman Pengorganisasian Instalasi Farmasi; Mempelajari Panduan UDD; Mempelajari Panduan <i>Floorstock</i> ; Mempelajari Panduan Resep; Mempelajari Panduan Obat yang Perlu Diwaspadai; Mempelajari Panduan Bahan Berbahaya dan Beracun; Mempelajari SPO Instalasi Farmasi.	4 jam	Ceramah, membaca, dan diskusi	Kepala IFRS
3	Mempelajari dan praktek alur pelayanan farmasi rawat jalan; Cara menerima resep rawat jalan. Mempelajari aplikasi BPJS; Menyiapkan dan etiket obat pasien rawat jalan; Menyerahkan obat dan KIE pasien rawat jalan; Checklist dan format data yang harus dikerjakan tiap akhir shift.	3 jam	Ceramah, diskusi, dan praktek	Apoteker rawat jalan
4	Mempelajari dan praktek alur pelayanan farmasi rawat inap; Cara menerima resep rawat inap; Menyiapkan dan etiket obat pasien rawat jalan IGD; Menyerahkan dan KIE pasien rawat jalan IGD; Menyiapkan obat pasien rawat inap; Checklist dan format data yang harus dikerjakan tiap akhir shift.	7 jam	Ceramah, diskusi, dan praktek	Apoteker rawat inap
5	Menyiapkan dan etiket obat pasien rawat inap; Mempelajari alur UDD; Serah terima obat dengan sistem UDD.	7 jam	Ceramah, diskusi, dan praktek	Apoteker rawat inap
6	Mempelajari <i>items</i> pada SIMRS depo farmasi rawat inap dan depo farmasi rawat jalan; Mempelajari proses permintaan barang	7 jam	Ceramah, diskusi, dan praktek	PJ shift

	ke Gudang Farmasi; Mempelajari proses penerimaan barang dari Gudang Farmasi; Proses penataan obat dari Gudang Farmasi.			
7	Mempelajari <i>items</i> pada SIMRS gudang farmasi; Mempelajari cara penerimaan barang dari distributor; Mempelajari cara pemesanan barang ke unit pengadaan; Mempelajadi cara input faktur.	7 jam	Ceramah, diskusi, dan praktek	Apoteker koordinator penerimaan, distribusi, dan produksi

BAB X

PERTEMUAN RAPAT

Rapat merupakan suatu pertemuan yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk membicarakan atau memecahkan suatu masalah tertentu. Tujuannya sebagai berikut :

1. Dapat membantu terselenggaranya pelayanan farmasi yang profesional di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada.
2. Dapat menggali segala permasalahan terkait dengan pemberian pelayanan di Instalasi Farmasi.
3. Dapat mencari jalan keluar atau pemecahan permasalahan yang terkait dengan pelayanan di Instalasi Farmasi.

10.1 Rapat Rutin

Rapat rutin terdiri dari :

1. Rapat koordinasi antar unit diselenggarakan pada setiap jumat jam 13.00 s/d selesai di Hall Sakura Lantai 5 RS Prima Husada Malang. Rapat ini dihadiri oleh kepala instalasi, kepala ruangan, dan unit-unit terkait untuk membahas tentang koordinasi antar unit dalam satu RS.
2. *Daily report* dilakukan setiap hari jam 13.30-15.00 yang bertempat di Ruang Direktur. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing unit untuk membahas permasalahan di masing-masing unit serta update informasi terbaru mengenai RS Prima Husada.
3. Rapat internal Instalasi Farmasi dilakukan 1 bulan sekali. Rapat ini dihadiri oleh seluruh tim Instalasi Farmasi RS Prima Husada termasuk apoteker dan Tenaga Vokasi Farmasi untuk membahas permasalahan internal ataupun eksternal, koordinasi internal, *update* keilmuan, dan lain-lain.

10.2 Rapat Insidentil

Rapat Insidentil terdiri dari :

1. Rapat Insidentil diselenggarakan sewaktu-waktu bila ada masalah atau sesuatu hal yang perlu dibahas dan sosialisasi kebijakan baru.

BAB XI

PELAPORAN

11.1 Laporan Harian

Laporan harian terdiri dari :

1. Laporan rekapan harian
Laporan rekapan harian meliputi tanggal laporan, shift yang bertugas, total resep keseluruhan, total resep rawat jalan dan rawat inap, total resep umum, total resep BPJS, total resep asuransi lain, yang dilakukan oleh Tenaga Vokasi Farmasi setiap harinya. Apoteker yang bertanggungjawab mengolah data tersebut dan melaporkan pada kepala instalasi setiap 6 bulan.
2. Laporan insiden keselamatan pasien
Laporan yang dilakukan pada setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien, yang dilakukan oleh apoteker atau Tenaga Vokasi Farmasi dan dituliskan ke dalam Formulir Laporan Insiden Internal ke Tim KP di RS dan melaporkan pada kepala instalasi untuk dilaporkan ke Tim Keselamatan Pasien RS.
3. Laporan indikator mutu
Laporan indikator mutu meliputi judul indikator mutu instalasi farmasi yang dikumpulkan oleh penanggungjawab pengumpul data. Apoteker yang bertanggungjawab mengolah data tersebut dan melaporkan pada kepala instalasi setiap bulan.
4. Laporan rapor dokter
Laporan rapor dokter meliputi tanggal laporan, ketidakterbacaan resep, ketidaklengkapan resep, kesalahan penulisan, polifarmasi, resep diluar formularium, serta prosentase hasil yang dilakukan oleh Tenaga Vokasi Farmasi setiap harinya. Apoteker yang bertanggungjawab mengolah data tersebut dan melaporkan pada kepala instalasi setiap bulan.

11.2 Laporan Bulanan

Laporan bulanan terdiri dari :

1. Laporan penggunaan obat narkotika dan psikotropika
Laporan penggunaan obat narkotika dan psikotropika dilaporkan oleh kepala instalasi farmasi melalui SIPNAP secara *online*. Data penggunaan diperoleh dari kesesuaian resep dengan data peresepan pada SIMRS. Data tersebut yang menjadi data pelaporan narkotika dan psikotropika tiap bulannya.
2. Laporan jadwal dinas tenaga kefarmasian
Laporan jadwal dinas apoteker disusun oleh kepala instalasi farmasi yang disetujui oleh kepala bidang penunjang medis, sedangkan jadwal dinas Tenaga Vokasi Farmasi disusun oleh apoteker pendamping yang disetujui oleh kepala instalasi farmasi dan kepala bidang penunjang medis.
3. Laporan *stok opname*
Laporan *stok opname* dilaporkan oleh apoteker dibantu Tenaga Vokasi Farmasi dengan cara menginput pada *billing* SIMRS hasil *stock opname* sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai tiap akhir bulan di instalasi farmasi dan Floorstok IKO.
4. Laporan bulanan unit
Laporan bulanan unit disusun oleh kepala instalasi farmasi yang melaporkan kebutuhan jumlah SDM, fasilitas, pengembangan pelayanan, kinerja produktivitas, mutu, evaluasi jadwal kegiatan, serta kritik dan saran dalam rangka perbaikan instalasi farmasi.

11.3 Laporan Tahunan

Laporan tahunan terdiri dari :

1. Laporan kajian sistem pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat

Laporan akhir tahun IFRS berisikan rekapitulasi tahunan pelayanan resep IRNA, IRJA, dan IGD yang disusun oleh kepala instalasi farmasi dibantu apoteker dalam mengolah data yang diperoleh dari hasil rekapan pelayanan resep tiap hari yang dilakukan oleh Tenaga Vokasi Farmasi.

Laporan rekapitulasi tahunan ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan resep di instalasi farmasi sehingga dapat dilakukan perencanaan penambahan SDM apabila diperlukan.

Laporan kajian sistem pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat yang dilakukan setiap tahun. Kajian meliputi proses perencanaan sistem pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat; pemilihan, perencanaan dan pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP; penyimpanan; pendistribusian; peresepan; penyiapan; pemberian obat; pemantauan terapi obat; laporan insiden kesalahan obat (*medication error*). Pelaksanaan kajian melibatkan Komite Farmasi dan Terapi, Komite Mutu dan Apoteker.

Kajian sistem pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat bertujuan agar Rumah Sakit memahami kebutuhan dan prioritas perbaikan sistem berkelanjutan.

2. Laporan evaluasi kinerja individu

Laporan akhir tahun IFRS berisikan evaluasi kinerja apoteker dan Tenaga Vokasi Farmasi terdiri dari evaluasi perilaku, pengembangan profesional, dan kinerja.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 30 Mei 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



dr. Nur Mazidah